EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 76559
SERVICIO : MEL HOMBRES HSC
FECHA : 2023-12-29 10:49:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: LUCILA DEL CARMEN BADILLA SOTO			RUN	: 6.965.790-7
F.Nac	: 14-05-1949	Edad	: 74 AÑOS, 7 MESES	Género	: Femenino
Dirección	: OHIGGINS 941			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA B	Teléfono	: 78631722		
Fecha Ingreso	: 2023-12-24	Fecha Egreso	: 2023-12-29 10:49:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. J18.9-NEUMONIA, NO ESPECIFICADA

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

1-INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA HIPOXEMICA
1.1-EPOC EXACERBADO
2 CA OVARIO CON MT PULMONAR
3-ICC?
4-HTA

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. J96.0-INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)
2. J44-OTRAS ENFERMEDADES PULMONARES OBSTRUCTIVAS CRONICAS (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
3. C56-TUMOR MALIGNO DEL OVARIO (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
4. I10-HIPERTENSION ESENCIAL(PRIMARIA) (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente con diagnostico de Ca de Ovario con Mt pulmonar en cuidados paliativos hace 1 año aproximadamente, usuaria de o2 en domicilio, es traida por SAMU por presentar exacerbacion de dianea basal y desaturación. Ingresa a urgencias en malas condiciones generales, GAS 7.33 PCO2 29.3 PO2 82 HCO3 145.5 PAFI 166 PCR 248 leucocitos 17500. Se recibe en sala disneica, con UMA, desaturando SatO2 82-84 con MV a 50%. Se inicia ceftriaxona y azitromicina, con disminución parámetros inflamatorios y buena respuesta clínica, con disminución progresiva del uso de O2 suplementario . Scanner abdomen pelvis: ca metastasico ovarico con signos de compromiso secundario macroscopico. Scanner torax: extensa neoplasia abdominal, compromiso metastasico difuso del parenquima pulmonar ganglionar hiliar y mediastinico , aterioesclerosis severa de la aorta. Paciente con uso 02 suplementario por NRC con FiO2 28%, sin apremio ventilario sin uso de musculatura accesoria, con mp + hasta las bases, crepitos aislados bibasales, se decide completar tto atb 10 días via HODOM , ya que paciente cuenta con O2 domiciliario.

INDICACIONES AL ALTA

1. HODOM
2. REPOSO RELATIVO
3. REGIMEN HIPOSODICO
4. USO O2 NARICERA PARA SATURAR MAYOR O IGUAL 90%
5. CEFTRIAXONA FRASCO 1 GRAMO 2 frasco cada 24 hrs. Por 3 dias
6. AZITROMICINA COMPRIMIDO 500 MILÍGRAMOS 1 comprimido cada 24 hrs. Por 3 dia
7. IPRATROPIO INHALADOR FRASCO UNIDAD 4puff cada 4hrs

8. SALBUTAMOL INHALADOR 100 MICROGRAMOS / DOSIS 2puff cada 8hrs
9. FLUTICASONA/SALMETEROL INHALADOR 250 MICROGRAMOS / 25 MICROGRAMOS 4puff cada 12hrs
10. LACTULOSA SOLUCIÓN 65% FRASCO 200 MINILITROS 15cc vo cada 12hrs
11. KNT RESPIRATORIA

CAMILA COLLAO ITURRA
MEDICO TRATANTE
19088566-6

JEFE SERVICIO